

NEWSLETTER ABRIL 2026

INDICE:

Noticias Medicas Relevantes	1
Industria Farmacéutica Internacional	3
Industria Farmacéutica Local	5
Otras Noticias Medicas	8
Droguerías y Cadenas de Farmacias	11
Noticias del Mercado de Salud Argentino	12
Notas de Fondo	14

NOVEDADES MEDICAS RELEVANTES

MENOS ES MEJOR: LOGRAR NIVELES MENORES DE COLESTEROL LDL (LDL-C) REDUCE LOS EVENTOS CARDIOVASCULARES EN ENF. ATEROESCLEROTICA

Un estudio realizado en Corea del Sur y publicado en el NEJM aleatorizo 3044 pacientes con demostrada enfermedad cardiovascular (EC con angina estable, IAM previo, angina inestable y cualquier forma de revascularización 89%, ACV 4% y Enf. Vascular periférica 8%) a dos niveles de colesterol LDL: Grupo Intensivo (GI): 55 mg/dl y Grupo Convencional (GC): 70 mg/dl.

Para lograr estos niveles se utilizaron altas dosis de estatinas en el 54% del GI y 34% GC; ezetimibe en 56 y 53% respectivamente y los inhibidores de PCSK9 en solo el 2,3 y 0,8%. Los niveles medios de LDL-C fueron en GI 56 mg/dl (Rango IQ: 48-67) y en el GC de 66 mg/dl (rango IQ 58-76)

La variable de resultado final (outcome) fue la combinación de muerte CV, IAM no fatal, ACV no fatal, cualquier forma de nueva revascularización o internación por angina inestable. Al cabo de tres años presentaron la variable de resultado 100 pacientes en GI (KM 6,6%) y 147 (KM 9,7%) en el GC HR: 0,67 (IC95% 0,52 a 0,82 P=0,002). No se observó diferencia en los eventos adversos, salvo que la creatinina aumentó más de 1,5 veces en 1,2% del GI y 2,7% en GC (P=0,004)

Un nivel objetivo de LDL-C de 55 mg/dl se asoció con una disminución significativa del riesgo a 3 años de un nuevo evento CV o muerte CV que cuando el nivel deseado es de 70 mg/dl.

N Engl J Med 2026;394:1365-1375

VACUNA CONTRA EL CANCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO

Un pequeño estudio publicado por autores alemanes en Nature muestra los resultados de un ensayo piloto con una vacuna generada a partir de las células tumorales de 14 pacientes con cáncer de mama triple negativo (un tipo de cáncer de mama de mal pronóstico). Luego de la secuenciación del ADN tumoral se identificaron en las pacientes casi 20 neoantígenos que fueron utilizados en vacunas basadas en mRNA para inocularse a cada paciente, es decir son vacunas personalizadas sobre la base de su propio tumor. El tiempo de generación de la vacuna fue de 69 días. Las pacientes recibieron las vacunas luego de completar la cirugía, neoadyuvancia o adyuvancia según el caso en un periodo de 64 días por un total de 8 dosis.

De las 14 pacientes 11 obtuvieron una respuesta inmune sólida (alto número de células T de memoria y citotóxicas contra antígenos tumorales) que perdura años después de la vacunación, mientras que en tres la respuesta fue débil y en estas pacientes hubo recurrencia de la enfermedad, mientras que las que generaron importantes respuestas están libres de recurrencia 6 años después de la vacunación.

Nature 2026, Febrero 18

APIXABAN VS RIBAROXABAN: ESTUDIO COMPARATIVO CON UN GANADOR

En un inusual estudio abierto, head-to-head se comparó en 2800 pacientes con diagnóstico de TVP o TEP en forma aleatorizada la eficacia y los efectos adversos de estos dos inhibidores directos de trombina. La tasa de recurrencia de la enfermedad tromboembólica fue similar en los dos grupos menor al 1 %, pero la variable de resultado compuesta por sangrado mayor o sangrado menor relevante fue el doble en el grupo de rivaroxabán (7,1% vs 3,3%). El sangrado mayor también fue más frecuente en el grupo de rivaroxabán (2,4 vs 0,4%). Es importante notar que la mayoría del sangrado con rivaroxabán se dio al final del primer mes de tratamiento.

El estudio demuestra que el apixaban es más seguro, aunque debe ser administrado en dos dosis diarias.

Castellucci LA et al N Eng J Med 2026; 394:1123 (Marzo 12/19)

INDUSTRIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL

BIOGEN ADQUIERE DERECHOS EN CHINA DE FELZARTAMAB POR HASTA 850 MILLONES

Este acuerdo asegura a Biogen el control global total sobre el felzartamab, la compañía no solo unifica su estrategia comercial, sino que lidera las terapéuticas para enfermedades renales primarias, de alta prevalencia en el sudeste asiático. El acuerdo con TJ Biopharma consta de un desembolso inicial de 100 M U\$S y un potencial de hasta 750M sujetos a metas comerciales.

El felzartamab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra CD38 que en la actualidad se encuentra en Fase 3 dirigido a la Nefropatía por IgA (Enf. De Berger) y nefropatía membranosa primaria. Además, esta pendiente en China la aprobación para el tratamiento del mieloma múltiple, donde TJ Biopharma será el fabricante local y Biogen lidera la comercialización.

NOTA DE DHC: TJ Biopharma es una empresa de biotecnología con base en Shanghái y Beijín que se especializa en anticuerpos monoclonales bioespecíficos y triespecíficos, además en anticuerpos de fusión proteica con citoquinas y anticuerpos conjugados con moléculas pequeñas. Esto le otorga un amplio desarrollo de potenciales terapéuticas para múltiples enfermedades desde la deficiencia de hormona de crecimiento en pediatría, cáncer de pulmón o gástrico y enfermedades autoinmunes. Una compañía que ya tiene alianzas con SANOFI además de Biogen.

ELI LILLY ESTÁ COMPRANDO LA BIOTECNOLÓGICA CONTRA EL CÁNCER KELONIA THERAPEUTICS POR MÁS DE 3 MIL MILLONES DE DÓLARES.

La operación: Eli Lilly adquirirá Kelonia Therapeutics por un total de hasta \$10.250 millones de dólares (\$3.25 mil millones por adelantado) operación que se cerrara en la segunda mitad de 2026.

El objetivo principal es el fármaco KLN-1010, una terapia génica de una sola aplicación para tratar el mieloma múltiple dirigida a BCMA que utiliza una estrategia innovadora, utilizando la plataforma iGPS, que permite crear células CAR-T directamente dentro del cuerpo del paciente, eliminando el complejo proceso de generación externa de CAR-T. Esto tendrá un impacto muy importante en el costo y la accesibilidad de esta innovadora terapia.

Con esta adquisición Lilly enfoca su estrategia por la edición genética y la oncología en conjunto con su reciente inversión en IA junto a Nvidia para el descubrimiento de fármacos.

BIOGEN COMPRARÁ APELLIS PHARMACEUTICALS POR 5.600 MILLONES DE DÓLARES EN UN IMPULSO A LAS ENFERMEDADES RARAS

Esta adquisición aportará a Biogen dos medicamentos inmunológicos comercializados y diferenciados: EMPAVELI®, aprobado por la FDA para tres indicaciones, incluidas dos enfermedades renales raras, y SYFOVRE®, aprobado por la FDA para la atrofia geográfica, una enfermedad retiniana de origen inmunológico.

MERCK (MSD) COMPRARÁ TERNS PHARMA POR 5.780 MILLONES DE EUROS

La farmacéutica Merck, conocida fuera de Estados Unidos y Canadá como MSD, ha suscrito un acuerdo definitivo para la adquisición de la biotecnológica estadounidense Terns Pharma con una valoración patrimonial de 6.700 millones de dólares (5.780 millones de euros), según ha informado la multinacional.

La adquisición de Terns Pharma supone la tercera gran compra en menos de un año que efectúa MSD, que ha estado realizando numerosas adquisiciones para adelantarse a la expiración de la patente de 'Keytruda', prevista para 2028, incluyendo la compra en julio de 2025 de Verona Pharma por unos 10.000 millones de dólares (8.627 millones de euros) y de Cidara Therapeutics, el pasado noviembre, por unos 9.200 millones de dólares (7.937 millones de euros).

GSK COMPLETA ADQUISICIÓN DE 950 MILLONES DE DÓLARES DE 35PHARMA DE CANADÁ

La operación: GSK (Glaxo) completó la compra de la biotecnológica canadiense 35Pharma por 950 millones de dólares.

El principal activo es la molécula HS235, diseñada para tratar la hipertensión pulmonar con mayor selectividad y menos efectos secundarios (como riesgos de sangrado) que los tratamientos actuales. El fármaco se probará próximamente para la hipertensión arterial pulmonar y la vinculada a insuficiencia cardíaca lo que expande sustancialmente el número de personas que potencialmente se beneficiarían de su uso.

Además de su función principal, estudios iniciales muestran que el HS235 favorece la pérdida de peso y mejora la sensibilidad a la insulina, beneficios clave para pacientes con obesidad.

INDUSTRIA FARMACEUTICA LOCAL

LAZAMIENTOS EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA LOCAL

1. Laboratorio Elea lanza presentación de Gilteritinib compitiendo con la de Gador

REG AB	MONODROGA	MARCA	PRESENTACION	LAB	PVP 15/04/26
64728	GILTERITINIB	GILTETIR	40 MG COMP.X 90	ELEA	38,286,627.00
61599	GILTERITINIB	XOSPATA	40 MG COMP. REC.X 84	GADOR	36,463,564.29

2. Laboratorio Gador lanza al mercado presentación en sobres granulados de ELEXACAFOR+TEZACAFOR+IVACAFOR para completar su line de tratamiento de pacientes con fibrosis quística. Esta presentación es única ya que todas las combinaciones existentes eran en comprimidos.

REG AB	MARCA	PRESENTACION	LAB	PVP 01/04/26
59041	TRIXACAR	COMP.REC. X 90	GADOR	16,169,738.18
59496	TRILEXA	COMP.REC. X 90	TUTEUR	15,257,863.80
60336	TRIXACAR P	COMP.REC. X 90	GADOR	10,457,567.49
61193	TRILEXA PEDIATRICO	COMP.REC.X 90	TUTEUR	10,686,162.72
64696	TRIXACAR P GRANULADO	SOBRES X 60	GADOR	13,071,959.36

3. Laboratorio Amgen lanza en Argentina el principio activo Tarlatamab de 1 y 10 mg (anticuerpo monoclonal) este novedoso fármaco esta indicado en el tratamiento del cáncer de pulmón a pequeñas células y posee la capacidad de unir la calcula cancerosa a un linfocito T ya que posee dos brazos activos. Es un tratamiento prometedor en una enfermedad agresiva con pocos avances de relevancia en los últimos tiempos.

REG AB	MONODROGA	MARCA	PRESENTACION	LAB	PVP 01/04/26
64642	TARLATAMAB	IMDELLTRA	1 MG/ML VIAL X 1	AMGEN	2,544,025.00
64643	TARLATAMAB	IMDELLTRA	10 MG/ML VIAL X 1	AMGEN	25,440,250.00

4. Laboratorio Biohope lanza en Argentina dos principios activos contra la misma patología uno el Inotersen, un fármaco indicado en el tratamiento de una forma poco frecuente de polineuropatía, la generada por amiloidosis familiar por transtiretina. Estudios contra placebo mostraron su eficacia en reducir la progresión de la enfermedad. Debido a que es un oligonucleótido sinsentido, es altamente probable que su costo sea muy elevado (sin PVP publicado por Alfa Beta). Por su parte el vutrisiran es una pequeña molécula doble hélice de RNA que interfiere con la expresión del gen de la transtiretina.

REG AB	MONODROGA	MARCA	PRESENTACION	LAB
64640	INOTERSEN	TEGSEDI	284 MG JER.PREL.X1.5ML X 4	BIOHOPE PHARMAC

REG AB	MONODROGA	MARCA	PRESENTACION	LAB
64641	VUTRISIRAN	AMVUTTRA	25 MG JER.PRELL. X0.5 ML	BIOHOPE PHARMAC

UN CASO TESTIGO EN LA GUERRA GLOBAL DE PRECIOS DE UNA DROGA CLAVE CONTRA EL CÁNCER

Competencia histórica: Argentina se convirtió en el primer país del mundo en lanzar un biosimilar del pembrolizumab (Pembrox, del laboratorio local ELEA) para competir con Keytruda, uno de los medicamento estrella de la multinacional Merck (MSD). Esta introducción indujo una muy importante caída en el precio, el laboratorio Merck debio bajar su precio un 49%. En la última licitación del Ministerio de Salud, ELEA ganó al ofertar un valor 56% menor al que Merck.

ELEA aprovechó que Merck no patentó la droga en Argentina a tiempo. Al vencerse los plazos legales de registro de propiedad inventiva, el laboratorio del Grupo Sigman pudo desarrollar su propia versión biotecnológica sin enfrentar demandas.

Impacto en la salud pública: Gracias a la baja de costos, el Estado pasó de comprar 280 dosis anuales a casi 4.000 en 2025 (un aumento del 1.300%), ampliando drásticamente el acceso para pacientes con diversos tipos de cáncer.

Ampliamente se considera que el biosimilar tiene una efectividad equivalente a la droga original. Además, la ANMAT flexibilizó recientemente las normas para facilitar la aprobación de este tipo de medicamentos de alto costo.

CAMBIO DE HÁBITO: LOS MEDICAMENTOS INDIOS SON LOS MÁS DISPENSADOS EN FARMACIAS

Cambio en el mercado: La eliminación de las Guías de Patentabilidad por parte del gobierno genera incertidumbre sobre el suministro de genéricos, ya que podría frenar la llegada de opciones más baratas.

Liderazgo de India: India se convirtió en el principal proveedor de drogas para Argentina (15,7% de la facturación), superando por primera vez a la producción nacional en el último tramo de 2025.

Datos del INDEC: La industria facturó casi 3 billones de pesos en el trimestre (un 30% más interanual). Aunque la producción nacional representa el 66% de las ventas, los insumos importados ganan terreno.

Medicamentos más vendidos: Los tratamientos oncológicos e inmunológicos lideran el mercado con el 24,5% de la facturación total.

El caso Mendoza: La provincia ahorró más de 6.500 millones de pesos importando medicamentos directamente de India a través de la OPS. A pesar de los debates sobre la falta de aval de agencias de EE. UU. o Europa, el gobierno nacional respalda esta estrategia para fomentar la competencia y bajar precios.

NOTICIAS MEDICAS

SIMPLE INTERVENCION PARA REDUCIR EL RIESGO DE ACV HEMORRAGICO.

El estudio TRIDEN publicado en el N Eng J Med aleatorizo 1:1 a 1670 pacientes a recibir un comprimido con: 20 mg de telmisartán+2,5 mg de amlodipina + 1,25 mg de indapapida o placebo por sobre el tratamiento habitual si luego de haber sufrido un ACV hemorrágico tenían la presión arterial sistólica entre 130 y 160 mm Hg. La edad media fue de 58 años y el seguimiento se prolongo por SOLO 30 meses.

El endpoint primario fue la recurrencia del ACV hemorrágico y los secundarios eventos CV o fallecimiento. Presentaron recurrencia de la hemorragia cerebral 38 (4,6%) de los pacientes en triple terapia y 62 (7,4%) en el grupo de placebo. HR 0,61 (IC95%: 0,41 0,92 p= 0,02), también se observó una reducción significativa de los eventos cardiovasculares en general (6,6 vs 9,8% p=0,04)

El tratamiento con tres antihipertensivos en bajas dosis se asoció con una significativa reducción de un nuevo ACV o nuevos eventos CV.

N Eng J Med 2026; 394:1571-82

EFFECTOS DE DIFERENTES ANTIBIOTICOS SOBRE LA MICROBIOTA INTESTINAL

Esta establecido que la composición de la microflora intestinal aparece cada vez mas relacionada con la salud humana (diarrea, cáncer de colon, diabetes o enf.CV), también está establecido que el uso de antibióticos (ATB) la altera en forma relevante. Lo que no esta establecido es la magnitud del daño de cada antibiótico y especialmente la duración del mismo. Investigadores suecos publicaron en Nature Medicine un estudio en el que evaluaron especímenes fecales de 15.000 pacientes enrolados en estudios prospectivos, casi 70% de los pacientes recibieron al menos un curso de ATB orales a lo largo de los 8 años de seguimiento.

Los hallazgos principales muestran que solo un curso de ATB altera la microbiota con un efecto prolongado generando disminución de algunas especies y sobrecrecimiento de otras, cuanto mayor cursos mas profunda y prolongada es la alteración. Los ATB con mayor daño y duración del mismo incluyen a la clindamicina, todas las fluoroquinolonas y la flucoxacina. Mientras que los que menos efectos tienen son la penicilina V, amoxicilina, TMP-SM y la nitrofurantoina. Es destacable que hubo en Suecia poca exposición a la ampicilina-clavulánico aunque el daño parece ser leve.

Baldazini G et al Nat Med 2026, Mar 11

LA ELASTORAGIA HEPATICA TIENE EL MISMO VALOR PREDICTIVO QUE LA BIOPSIA EN LA ESTEATOSIS HEPATICA ASOCIADA A DISFUNCION METABOLICA (MASLD)

Un estudio reciente de 3500 adultos con una edad media de 52 años y un tercio de los cuales tenían fibrosis hepática avanzada, que fueron sometidos a ambos métodos pronósticos (punción biopsia y elastografía por vibración controlada transitoria) mostraron que en un seguimiento de 5 años el objetivo primario: descompensación de hepatopatía, trasplante de hígado o fallecimiento relacionado a cirrosis fue predicho con la misma exactitud.

Adicionalmente la elastografía estratifico correctamente según la magnitud de la rigidez: el objetivo primario se produjo en 0,3% de los pacientes con < 10 KPa, en 3% en aquellos entre 10 y 20 kPa y en 14% con mas de 20 kPa.

Conclusión: El uso de la elastografía sustituye la estadificación de MASLD por punción biopsia

Hepatology 2025 Diciembre 24

NO TODOS LOS BROCODILADORES SON IGUALES EN EL EPOC

La recomendación de las guías de practica para el tratamiento del EPOC fundan la prevención en el uso combinado de agonistas muscarínicos de vida media larga (LAMA) junto a agonistas $\beta 2$ de larga acción (LABA). Un estudio publicado recientemente por JAMA Internal Medicine comparo:

- Umeclidinium-vilanterol
- Tiotropio-olodaterol
- Glicopirronio-formoterol

El estudio demostró que Umeclidinium-vilanterol tuvo una reducción modesta pero significativa de los episodios de exacerbación de EPOC definidos como uso de corticoesteroides en ambulatorio + hospitalizaciones por reagudización. Toda la diferencia se observó en la necesidad de corticoides ambulatorios, ya que las hospitalizaciones fueron similares.

JAMA Intern Med 2026 Feb 23

DOS ESTUDIOS CONFIRMAN QUE EL SEMAGLUTIDE NO TIENE EFECTO EN LA EVOLUCION DEL ALZHEIMER TEMPRANO

Existía evidencia en animales y en pacientes con diabetes que el semaglutide podía modificar la evolución de la enfermedad en etapas tempranas.

Se publico recientemente en The Lancet los resultados del estudio Evoke y Evoke+ en el que 3808 pacientes fueron aleatorizados a recibir placebo o semaglutide en dosis de 14 mg flexible y evaluados a las 104 semanas. Los resultados mostraron que la evolución de pacientes con formas leves de Alzheimer no fue modificada con respecto a placebo ($p=0,54$) por el semaglutide. Los efectos adversos y eventos de seguridad fueron similares a los reportados en otros estudios.

The Lancet 2026; marzo 19

LEVE INCREMENTO DEL RIESGO DE ACV EN PACIENTES QUE INICIAN TRIPTANOS

Cierta evidencia observacional mostraba un incremento del riesgo de ACV isquémico en pacientes que inician triptanos, para definir la asociación y le grado de incremento del riesgo, los investigadores efectuaron el análisis de una cohorte de 870.000 personas en EEUU con una media de edad de 40 años y un 78% de mujeres, se calculó el riesgo de los que inician triptanos contra los que no, luego de ajustar por características basales.

Los resultados mas relevantes confirman que con un seguimiento medio de 7 años la incidencia de ACV isquémico fue mayor en aquellos que inician triptanos 3,4 contra 1,7 eventos por 1000 personas/año. Lo que representa un pequeño incremento del riesgo, pero es importante observar que eran pacientes jóvenes, por lo que en una población con mayor riesgo cardiovascular el incremento podría ser mayor.

Kalapura C et al J Am Heart Assoc 2026 17 de febrero

DROGUERIAS Y REDES DE FARMACIAS

ROBOTS DE ALTA PRECISIÓN TRANSFORMAN LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS EN DROGUERÍA SUR (BAHIA BLANCA)

Hito regional: La empresa de tecnología médica BD, junto a su distribuidor Automatiza SA, implementó en la casa matriz de Droguería Sur (Bahía Blanca) el proyecto de automatización robótica más grande de América Latina para un centro de distribución farmacéutico.

Tecnología aplicada: Se instalaron tres robots BD Rowa™ Vmax160 con sistema de carga automática. Esta infraestructura permite gestionar más de 20.000 referencias de productos, automatizando el proceso desde la recepción hasta el despacho final.

Impacto operativo: La automatización reduce los tiempos de entrega a un rango de 8 a 12 segundos por medicamento y optimiza el abastecimiento de más de 1.500 farmacias en el sur argentino (desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego).

Factor humano: El sistema busca eliminar errores mecánicos y tareas repetitivas, permitiendo que los 300 colaboradores de la droguería se enfoquen en tareas de gestión estratégica y atención personalizada.

Eficiencia: Los robots operan con un 99,9% de confiabilidad, lo que consolida a Argentina como uno de los mercados más dinámicos de la región en la adopción de tecnología logística para la salud.

DROGUERÍAS COFARMA-MONUMENTO-VENETO FARMACIA-ORIENTAL-FARMACIA KID GRAL: ACTUALIZACION DE IMPORTES POR REMITOS (ABRIL-MAYO 2026)

Informamos los nuevos honorarios que regirán, a partir del Período ABRIL/ MAYO 2026, en concepto de dispensa efectuada por las farmacias y gastos de envío.

Por cada dispensa efectuada por las Farmacia, considerándose un solo pago por cada remito u orden de entrega, independientemente de la cantidad de medicamentos que se incluyan en ese mismo acto dispensatorio, el importe se ha fijado en \$31.338- (pesos treinta y un mil trescientos treinta y ocho) IVA incluido, se aplicará recupero de gastos por remitos en \$1000.

En concepto de gastos de envío, FACAF facturará la suma \$14.400 (pesos, catorce mil cuatrocientos) IVA incluido, por cada farmacia que eleve remitos para su liquidación.

Se aclara que el costo de envío no se aplica para la DROGUERÍA ORIENTAL.

NOTICIAS DEL MERCADO DE LA SALUD ARGENTINA

NUEVA LEY DE DISCAPACIDAD: NUEVO PROYECTO DE LEY PRESENTADO POR EL GOBIERNO

El Gobierno nacional envió al Congreso una propuesta para modificar la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (N°27.793). La iniciativa busca auditar el sistema, pero ha generado un fuerte rechazo de colectivos de personas con discapacidad, quienes denuncian una quita de derechos y marcharán este miércoles al Ministerio de Salud. Los impactos y cambios principales son:

Reempadronamiento obligatorio: Todos los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, social y laboral. El incumplimiento o la detección de "casos dudosos" resultarán en la suspensión de la pensión.

Incompatibilidad laboral: El proyecto establece que tener un trabajo formal será incompatible con el cobro de la pensión eliminando los programas de inclusión laboral y obligando a elegir entre un empleo registrado o el beneficio estatal.

Recortes económicos: El monto se fija en el 70% de la jubilación mínima, pero se eliminan los adicionales por zona desfavorable e invalidez laboral. Las prestaciones tasan de actualización mensual (IPC) a trimestral.

Desregulación y Financiamiento: Se derogan artículos clave de la Ley 27.793, quitando al Estado la obligación de cumplirla. También se autoriza la descentralización de fondos a provincias, lo que desregula el nomenclador nacional de prestaciones y afecta la negociación con obras sociales y prepagas.

UN GRUPO HACKER AMENAZA CON UNA MEGA FILTRACIÓN DE DATOS EN LA ARGENTINA

La Amenaza: El grupo hacktivista Chronus Team anunció una "mega filtración" de datos para el 30 de marzo, afectando a 17 instituciones argentinas.

Organismos Afectados: Entre los objetivos figuran el Banco Central, la Corte Suprema, el Ministerio de Salud y obras sociales como IOMA (Buenos Aires) y OSEP (Mendoza). Pero La OSEP de Mendoza negó oficialmente haber sufrido una intrusión en sus sistemas.

Origen y Método: Es un clúster de activistas con base en México. No son espías sofisticados; aprovechan fallas comunes como sistemas desactualizados o contraseñas reutilizadas.

Incertidumbre: Los expertos advierten que el anuncio puede ser propaganda para generar miedo o exagerar sus capacidades, aunque el riesgo es real dada su actividad previa en otros países de la región.

ARGENTINA FORMALIZÓ SU RETIRO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

El canciller, Pablo Quirno, anunció que Argentina hizo efectivo decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación”, escribió el mandatario. Cabe destacar que Argentina continúa siendo parte de la OPS.

GABRIEL LEONARDO BARBAGALLO ASUME COMO SUBADMINISTRADOR DE ANMAT

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informa que el Gobierno nacional designó al Dr. Gabriel Leonardo Barbagallo como subadministrador nacional del organismo. El Dr. Barbagallo es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) donde fue docente. . Cuenta con una extensa experiencia laboral corporativa en OSDE, donde ocupó cargos de alta responsabilidad. También fundó la primera asociación de

NOTAS DE FONDO

ANÁLISIS DE LOS ÚLTIMOS FALLOS EN MATERIA DE SALUD CON LA INTERVENCIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Por Mariano Macedo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación no suele intervenir de manera frecuente en la resolución de cuestiones sustanciales relacionadas con la Salud, ya sea por la vía de recurso de amparo o por la vía ordinaria, salvo cuando entran en conflicto cuestiones de competencia Federal o cuando debe pronunciarse a fin de asegurar el respeto por el marco normativo -en sentido amplio- que desde 1994 otorga rango Constitucional con jerarquía superior a las leyes o decidir sobre la procedencia de su reglamentación.

Como su jurisprudencia troncal se mantiene estable en este sentido, en este apartado examinamos una serie de decisiones tomadas por el Superior Tribunal en el último año y medio, específicamente en casos relacionados con el ejercicio del derecho a la salud.

Nuestro objetivo es resaltar el enfoque adoptado y la jurisprudencia que se desprende de dichos fallos.

a. Cirugía en el extranjero y limitación reglamentaria.

En el último fallo sobre esta materia, la Corte recurrió a su reconocida jurisprudencia respecto al carácter fundamental del derecho a la salud y la especial protección que requieren las personas con discapacidad. El Tribunal reiteró que estos derechos, de raigambre constitucional, como los principios y garantías consagrados en la Carta Magna, no son absolutos y deben ejercerse conforme a las leyes que regulan su ejercicio, siempre que no se altere su esencia.

Bajo esta premisa, consideró arbitraria una sentencia que autorizaba la realización de una operación en el extranjero, contraviniendo el reglamento de la Caja de Seguridad Social para Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, el cual establece un límite de gastos para esa finalidad.

La Corte cuestionó el proceder del magistrado que se basó únicamente en el informe forense para admitir la pertinencia de la intervención en el exterior, sin valorar que el peritaje también indicaba que la cirugía podía realizarse en el país, y que la técnica recomendada ya se utilizaba localmente con resultados satisfactorios.

Aunque la Cámara reprochó a la demandada la falta de prueba sobre el menor costo, se acreditó que, según el valor oficial del dólar de ese momento, cada intervención en Argentina era aproximadamente siete veces más económica que en el extranjero. En consecuencia, el Superior Tribunal dejó sin efecto el fallo y rechazó la acción.

b. Competencia federal en reclamos de cobertura a Swiss Medical y OSDE.

En un amparo contra una empresa de medicina prepaga por la provisión de diversas prestaciones médicas a una paciente con certificado de discapacidad, se generó un conflicto negativo de competencia. El juez federal declinó intervenir, argumentando que la demanda implicaba determinar tratamientos y que, al no estar la afectada en condiciones de decidir sobre su estado de salud, debía actuar el fuero nacional en lo civil, donde se tramitaba un proceso para establecer su capacidad jurídica. Por otro lado, la magistrada nacional rechazó la radicación aduciendo que el reclamo involucraba normas y principios trascendentes para el sistema de salud nacional.

La Corte resolvió que correspondía a la justicia en lo civil y comercial federal entender en la causa, considerando que el objeto del litigio conducía al análisis de las obligaciones de las empresas de medicina prepaga y que los procesos relativos a situaciones reguladas por normas federales deben tramitar ante ese fuero.

En otro caso, se originó un conflicto negativo de competencia en una demanda que buscaba obligar a OSDE a cubrir íntegramente un tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad. El juzgado nacional sostuvo que su resolución requería interpretar leyes federales, mientras que el juzgado civil y comercial federal rechazó la radicación del expediente, argumentando que debía tramitar ante la justicia federal de la provincia debido a la localización de la institución y la profesional involucrados.

La Corte entendió que la discusión involucraba la interpretación de la Ley 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida, norma federal y de orden público con vigencia en todo el territorio argentino, que abarca a todos los prestadores del servicio de salud, tanto públicos, de seguridad social y privados. Así, el proceso debía tramitar ante el fuero federal.

c. Competencia federal en reclamos de mala praxis contra obras sociales.

El Tribunal Superior adoptó una solución similar en el marco de una demanda por mala praxis médica, donde también se originó un conflicto negativo de competencia entre los mismos fueros.

La Corte declaró la competencia de la Justicia en lo Civil y Comercial Federal para intervenir, dado que la obra social accionada estaba comprendida en los términos de las leyes 23.660 y 23.661, y que el reclamo del actor se basaba en la falta de cumplimiento del deber de seguridad relacionado con la prestación médico asistencial obligatoria. Por tanto, el objeto del proceso requería la interpretación de leyes federales.

d. Las costas a la vencida, aunque sea el PAMI, es decir el Estado.

En un caso en el que la cámara confirmó un amparo por prestaciones médicas, modificó la decisión únicamente respecto a la imposición de costas,

distribuyéndolas por su orden en ambas instancias. La demandada presentó un recurso extraordinario, alegando la afectación de sus derechos de propiedad y debido proceso.

La Corte dejó sin efecto la sentencia apelada que había impuesto las costas por su orden, considerando que el artículo 68 del Código Civil y Comercial de la Nación era inaplicable en este caso. En procesos de amparo, las costas deben imponerse según el artículo 14 de la ley 16.986, que establece que la parte vencida debe asumirlas, salvo que antes de la contestación del informe previsto en el artículo 8° de esa ley se produzca el cese del acto u omisión que motivó el amparo, situación que no se dio en este proceso.

En el próximo número desarrollaremos como tema de fondo la relación entre el derecho a la salud, su vigencia y efectividad en el marco de una política económica restrictiva en su financiamiento y la crisis que afecta al sistema y al ejercicio del derecho.